

EVALUATION : LES PERITONITES AIGUES

Cas clinique

Un patient âgé de 32 ans, qui consulte pour des douleurs épigastriques intenses évoluant depuis cinq jours, accompagnées de vomissements bilieux. L'interrogatoire met en évidence la prise récente de comprimés, dont la nature n'est pas précisée, prescrits à la suite d'une entorse de la cheville.

À l'examen clinique, le patient est fébrile à 39,6 °C, tachycarde à 132 battements par minute et présente une hypotension artérielle à 8/7 cmHg. L'abdomen est le siège d'une contracture généralisée, plus marquée au niveau de l'épigastre. Le toucher rectal déclenche une douleur vive.

Le diagnostic le plus probable est :

- A. Pancréatite aiguë grave
- B. Ulcère gastroduodéal perforé avec péritonite
- C. Occlusion intestinale haute
- D. Cholécystite aiguë lithiasique
- E. Hépatite aiguë virale

Devant ce tableau de péritonite généralisée, quel examen complémentaire est le plus indiqué en urgence ?

- A. Radiographie de l'abdomen sans préparation
- B. Scanner abdominal avec injection de produit de contraste

C. Échographie abdominale

D. Bilan hépatique

E. IRM abdominale

Quels sont les signes cliniques de gravité retrouvés chez ce patient ?

A. Fièvre à 39,6 °C

B. Tachycardie à 132 bpm

C. Hypotension artérielle 8/7

D. Contracture abdominale généralisée

E. Douleur au toucher rectal

Quelle est la conduite à tenir immédiate en attendant la chirurgie ?

A. Mise à jeun et réanimation hydro-électrolytique

B. Mise en place d'une sonde nasogastrique

C. Antibiothérapie probabiliste à large spectre

D. Antalgiques morphiniques uniquement

E. Oxygénothérapie et surveillance rapprochée

Cas clinique

Un homme de 45 ans, sans antécédents particuliers, est opéré pour une cholécystite aiguë lithiasique par cholécystectomie laparoscopique. L'intervention se déroule sans incident apparent.

À J2 postopératoire, le patient présente une fièvre à 38,8 °C, une tachycardie à 115 bpm, une tension artérielle à 9/6 cmHg, et se plaint de douleurs abdominales diffuses, majorées à la palpation. L'abdomen est sensible avec un début de défense généralisée. Le bilan biologique révèle une hyperleucocytose à 15 000/mm³ et une CRP à 180 mg/L.

Un drainage abdominal, mis en place per-opératoire, ramène un liquide verdâtre bilieux. L'échographie abdominale puis le scanner montrent un épanchement intra-péritonéal diffus compatible avec une fuite biliaire.

QCM 1 : Quel est le diagnostic le plus probable

- A. Péritonite stercorale
- B. Péritonite biliaire post-opératoire
- C. Pancréatite aiguë post-opératoire
- D. Péritonite tuberculeuse
- E. Abscès hépatique

QCM 2 : Quelle est la principale cause de cette complication?

- A. Lésion iatrogène de la voie biliaire principale
- B. Ulcère gastroduodénal perforé
- C. Nécrose pancréatique infectée

D. Appendicite compliquée

E. Traumatisme abdominal fermé

QCM 3 : les Examens complémentaires les plus utiles pour confirmer la fuite biliaire sont :

A. Scanner abdominal avec injection

B. Échographie abdominale

C. Bili-IRM

D. Bilan hépatique biologique

E. Radiographie thoraco-abdominale

QCM 4 : La conduite thérapeutique en urgence est basée sur :

A. Réanimation médicale (remplissage, antibiotiques)

B. Drainage chirurgical de l'épanchement péritonéal

C. Drainage scannoguidé

D. Mise en place d'une prothèse biliaire par CPRE (endoscopie)

E. Simple surveillance clinique

QCM

1- Les deux étiologies les plus fréquentes de la péritonite aigue sont :

- A- Les traumatismes de l'abdomen
- B- L'appendicite aigue
- C- La dialyse péritonéale
- D- La perforation d'ulcère gastro-duodéal
- E- La diverticulose colique

2- La péritonite aigue diffuse secondaire :

- A- Est l'apanage des patients immunodéprimés
- B- Survient uniquement en cas de perforation d'organe creux
- C- L'appendicite aigue en est souvent la cause chez l'enfant
- D- Est souvent polymicrobienne
- E- Nécessite toujours un traitement chirurgical

3- Dans le cadre d'une péritonite aigue généralisée, quelle constatation de l'examen clinique nous oblige à opérer le malade :

- A- Météorisme abdominal
- B- Toucher rectal sensible
- C- Contracture abdominale
- D- Faciès terreux
- E- Douleur provoquée de la fosse iliaque droite

4- La contracture abdominale est :

- A- Invincible
- B- Permanente
- C- Douloureuse
- D- Le témoin d'une péritonite

E- Présente dans toutes les formes de péritonite

5- Le syndrome péritonéal typique associe :

A- Une douleur abdominale diffuse

B- Une défense ou une contracture abdominale

C- Une polypnée

D- Une diarrhée

E- Une abolition des reflexes cutanés abdominaux

6- Dans une péritonite aigue secondaire, l'infection peut gagner la séreuse péritonéale par :

A- Effraction traumatique d'un viscère creux

B- Suppuration d'un organe intra abdominal

C- Rupture intra abdominale d'une suppuration

D- Voie sanguine

E- Voie lymphatique

7- La péritonite aigue bactérienne secondaire :

- A- Survient souvent spontanément
- B- Est la forme de péritonite la plus fréquente
- C- Inclut l'infection du liquide d'ascite chez le cirrhotique
- D- Présente une flore bactérienne monomorphe
- E- Peut être post opératoire

8- Concernant les péritonites aigues par perforation :

- A- Elles ont le plus souvent un début brutal
- B- Elles surviennent chez des sujets en mauvais état général
- C- Leur diagnostic est en général basé sur l'examen clinique
- D- Sur l'abdomen sans préparation il existe toujours un pneumopéritoine
- E- La contracture abdominale est généralement présente

9- La péritonite primitive :

- A- Est souvent polymicrobienne
- B- Nécessite souvent un traitement chirurgical
- C- Peut se voir à tout âge
- D- Est la forme la plus fréquente chez l'enfant
- E- Peut être due à une perforation d'organe creux

10- Concernant la péritonite bactérienne primitive :

- A- Son diagnostic est le plus souvent évident
- B- La contamination péritonéale peut se faire par voie hématogène
- C- L'infection du liquide d'ascite en est une étiologie fréquente
- D- Son traitement est basé sur une antibiothérapie adaptée
- E- L'incertitude diagnostique doit faire poser l'indication opératoire

11- Le pneumopéritoine :

- A- Est un signe constant à l'ASP en cas de perforation digestive
- B- Témoigne toujours de l'existence de germes anaérobie
- C- Est plus important en cas de perforation colique
- D- Est un signe péjoratif en cas de péritonite aigue
- E- Est constamment retrouvé en cas de forme grave de péritonite appendiculaire

12- Sur le cliché d'ASP le pneumopéritoine s'observe dans la perforation de tous

13- ces organes sauf un, lequel :

- A- L'estomac
- B- L'iléon
- C- Le colon sigmoïde
- D- L'appendice
- E- Le troisième duodénum

14- Parmi les signes suivants, lequel est toujours présent dans la péritonite généralisée par perforation d'UGD ?

- A- La douleur abdominale
- B- La contracture
- C- La fièvre
- D- Un syndrome occlusif
- E- Un pneumopéritoine

15- Quelles sont les étiologies possibles des péritonites aigues :

- A- Appendicite
- B- Perforation d'ulcère duodénal
- C- Pneumopathie basale
- D- Pyosalpinx
- E- Pancréatite aigue

16- La péritonite appendiculaire :

- A- Peut inaugurer l'évolution de l'appendicite aigue
- B- Est toujours secondaire à la perforation de l'appendice
- C- Est de meilleur pronostic si elle survient en trois temps
- D- Peut être traitée par voie laparoscopique
- E- Est souvent de mauvais pronostic

17- En faveur de l'origine appendiculaire d'une péritonite aigue :

- A- L'âge jeune
- B- Le début des douleurs au niveau de la fosse iliaque droite
- C- La brutalité d'installation du tableau
- D- La présence d'un important iléus reflexe
- E- Un bombement du cul de sac de Douglas au TR

18- La prise en charge de la péritonite appendiculaire impose :

- A- Une intervention chirurgicale en urgence
- B- Un prélèvement de pus à visée bactériologique
- C- Une toilette péritonéale
- D- Une appendicectomie
- E- Un drainage systématique de la cavité péritonéale

19- Le tableau d'une perforation d'ulcère gastro-duodéal :

- A- Est le plus souvent évident cliniquement
- B- Est caractérisé par un début brutal de la symptomatologie
- C- L'état septique du patient est souvent évident dès le début
- D- Peut inaugurer la maladie ulcéreuse
- E- Le traitement chirurgical n'est proposé qu'en cas d'échec de la méthode de Taylor

20- La perforation d'ulcère duodénal :

- A- Touche le plus souvent l'homme
- B- Peut inaugurer la maladie ulcéreuse
- C- Donne une péritonite chimique avant les 6 premières heures
- D- S'accompagne toujours de pneumopéritoine visible à l'ASP
- E- S'accompagne toujours de hoquet

21- Devant une péritonite aigue chez une femme jeune, quels sont les éléments d'orientation vers l'origine génitale :

- A- Le port de DIU
- B- Antécédents de salpingite
- C- La présence de pertes vaginales fétides
- D- Un bombement douloureux du cul de sac de Douglas
- E- Une douleur à la mobilisation utérine aux touchers pelviens

22- L'abcès de Douglas :

- A- Est une forme de guérison de l'appendicite aigue
- B- Est une forme de péritonite aigue purulente
- C- Peut donner des signes d'emprunt urinaires
- D- Les signes généraux sont souvent absents
- E- Se manifeste cliniquement par une contracture abdominale

23- Un abcès du cul de sac de Douglas :

- A- Peut être du à une appendicite pelvienne
- B- Peut donner un ténesme rectal
- C- Peut se manifester par une occlusion fébrile
- D- Peut être du à un pyosalpinx
- E- Peut donner des émissions glairo-sanglantes par l'anus

24- L'abcès sous-phrénique :

- A- Donne souvent un hoquet témoignant de l'irritation diaphragmatique
- B- Peut donner des manifestations respiratoires
- C- Un niveau hydro-aérique sous phrénique à l'ASP est un signe constant
- D- Est une complication classique des péritonites d'origine génitale
- E- Peut constituer une complication postopératoire d'un ulcère duodénal perforé

25- Le tableau d'abcès sous phrénique par perforation bouchée d'ulcère duodénal peut associer :

- A- Une fièvre
- B- Un tableau de sténose digestive haute
- C- Un hoquet
- D- Une douleur à la palpation de l'hypochondre droit
- E- Une douleur atroce au toucher rectal

26- La collection purulente d'un abcès appendiculaire :

- A- Est entourée d'une coque faite par l'agglutination d'organes de voisinage
- B- Peut être drainée sous contrôle scannographique
- C- Est une péritonite localisée
- D- Peut être traitée uniquement par antibiothérapie
- E- Peut siéger en rétro-caecal

27- L'apparition d'un abcès appendiculaire, dans l'évolution d'une appendicite aiguë

- A- Est favorisée par le traitement antibiotique d'une appendicite évolutive
- B- Est secondaire à une forme gangreneuse d'appendicite aiguë
- C- Aggrave le pronostic de l'appendicite aiguë
- D- Est rare chez l'adulte
- E- Peut être une complication d'un plastron appendiculaire

28- L'abcès du cul de sac de Douglas :

- A- Peut être la complication d'une appendicectomie
- B- Peut se manifester par une pollakiurie
- C- Donne un bombement au TR
- D- Ne se rompt jamais en péritoine libre
- E- Peut être traité par rectotomie antérieure

29- En faveur de la gravité d'une péritonite aigue on retient :

- A- La présence de signes toxi-infectieux
- B- La contracture abdominale
- C- L'insuffisance rénale
- D- Le terrain diabétique
- E- La perforation diastatique du colon comme étiologie

30- Le troisième secteur au cours de la péritonite aigue diffuse

- A- Est du à l'altération des capillaires péritonéaux
- B- Est du à l'iléus paralytique
- C- Est la traduction d'une fuite plasmatique péritonéale par transsudation
- D- Est une cause majeure d'hypovolémie
- E- Nécessite toujours l'administration de médicaments vaso-actifs

31- La péritonite stercorale :

- A- Est chimique au début
- B- Peut être asthénique
- C- Est de mauvais pronostic
- D- Témoigne souvent d'une perforation digestive distale
- E- Se voit surtout chez le sujet âgé

32- La péritonite asthénique :

- A- Est plus fréquente chez le sujet âgé
- B- Est généralement vue tardivement
- C- Les signes généraux sont discrets
- D- Les signes physiques sont discrets
- E- Son diagnostic est souvent évident

33- Les choix possibles de l'antibiothérapie des péritonites communautaires sans signes de gravité :

- A- Augmentin®+Flagyl®
- B- Tazocilline®+Gentamycine®
- C- Tiénam® +Flagyl®
- D- Claforan®+Flagyl®
- E- Augmentin®+Gentamycine®

34- Quelles propositions parmi les suivantes s'appliquent à l'antibiothérapie des péritonites appendiculaires ?

- A. hémocultures avant l'antibiothérapie
- B. examen bactériologique aérobie et anaérobie du liquide péritonéal au cours de la laparotomie
- C. antibiothérapie dirigée contre les cocci gram+
- D. antibiothérapie à large spectre incluant le métronidazole (Flagyl*)
- E. démarrage de l'antibiothérapie avant la laparotomie

35- Au cours de l'évolution d'un abcès sous phrénique par perforation couverte d'un ulcère duodénal, tous ces signes peuvent se voir sauf un, lequel ?

- A- Fièvre
- B- Etat subocclusif
- C- Vomissements
- D- Défense localisée
- E- Douleur au toucher rectal

36- L'examen clinique d'un patient présentant une péritonite aiguë généralisée par perforation d'ulcère gastroduodénal peut trouver :

- A- Un météorisme abdominal
- B- Une contracture abdominale
- C- Une disparition de la matité pré hépatique
- D- Un blindage pariétal au niveau de la FID
- E- Une immobilité abdominale à la respiration

37- Devant une suspicion de péritonite aiguë généralisée du sujet jeune, l'indication opératoire est formelle en cas de :

- A- Météorisme abdominal
- B- Toucher rectal douloureux
- C- Contracture abdominale
- D- Faciès péritonéal
- E- Douleur provoquée de la fosse iliaque droite

38- Citer 3 types de péritonite aigue selon leur mode de contamination et donner un exemple pour chaque type.

39- Donner 3 étiologies de l'abcès de Douglas.

40- Citer deux exemples de péritonite aigue localisée.

41- Citer deux signes sémiologiques retrouvés au TR témoignant de l'existence d'une péritonite aigue.

- 42- Quel est l'examen morphologique le plus sensible pour la détection du pneumopéritoine ?
- 43- Citer 3 étiologies de péritonite aigue secondaire par perforation.
- 44- Citer deux germes fréquemment isolés au cours des péritonites primitives.
- 45- Citer 5 étiologies coliques pouvant être à l'origine d'une péritonite aigue.
- 46- Citer 2 mécanismes à l'origine de péritonite post-opératoire.
- 47- Un homme de 32 ans consulte pour douleurs épigastriques intenses évoluant depuis 3 heures, associées à des vomissements bilieux. L'interrogatoire révèle la prise de comprimés non précisés prescrits à l'occasion d'une entorse de la cheville. L'examen trouve une T° à 37,6 °C, un pouls à 105 bpm, une tension artérielle à 13/7, une contracture abdominale et une douleur vive au toucher rectal.

Question 1 : En faveur du diagnostic de péritonite aigue généralisée par perforation d'ulcère gastroduodénal :

- A- L'heure précise du début de la symptomatologie
- B- Les vomissements bilieux
- C- La prise récente d'anti-inflammatoires non stéroïdiens
- D- Le siège épigastrique des douleurs
- E- La contracture abdominale

Question 2 : Quel est l'examen à réaliser de première intention dans ce cas pour étayer le diagnostic :

- A- La fibroscopie oeso-gastro-duodénale
- B- L'échographie abdominale
- C- La radiographie d'abdomen sans préparation debout
- D- Le scanner abdominal
- E- Le transit oeso-gastro-duodénal

Question 3 : Le traitement médical à entreprendre dans ce cas comporte :

- A- Un antispasmodique
- B- Un inhibiteur de la pompe à protons
- C- Une sonde naso-gastrique en aspiration
- D- Une rééquilibration hydro-électrolytique
- E- Une héparinothérapie à bas poids moléculaire

Question 4 : Le traitement chirurgical peut consister en :

- A- Une toilette péritonéale avec suture de la perforation par laparoscopie
- B- Une toilette péritonéale seule en cas de perforation de petite taille
- C- Une toilette péritonéale avec bivagotomie et pyloroplastie à la Judd
- D- Une fistulisation dirigée de la perforation
- E- Une intervention de Weinberg

48- Patient âgé de 75 ans diabétique et hypertendu, consulte pour syndrome occlusif évoluant depuis 5 jours avec aggravation des douleurs depuis 24 heures. A l'examen T= 38.5°C, TA= 10/8, pouls= 110 bpm, polypnéique à 26 cycle/min, l'abdomen est très distendu avec défense abdominale généralisée plus accentuée au niveau de la fosse iliaque droite. A la biologie GB = 15000 EB/mm³, CRP = 126, urée = 14 mmol/l. à l'ASP présence de multiples NHA coliques.

Question 1 : Quel diagnostic est le plus probable :

- A- Péritonite appendiculaire
- B- Péritonite par perforation d'ulcère gastro-duodénal
- C- Péritonite par perforation diastatique du caecum
- D- Péritonite par perforation d'une tumeur du colon sigmoïde
- E- Péritonite par perforation diverticulaire

Question 2 : En faveur de la gravité de cette péritonite :

- A- L'hyperleucocytose à 15000 E/mm³
- B- L'insuffisance rénale aigue
- C- La polypnée
- D- La nature stercorale
- E- La pression artérielle systolique à 10 cmHg

Question 3 : La prise en charge initiale de ce patient comporte :

- A- Une antibiothérapie à large spectre
- B- Une rééquilibration hydro-électrolytique
- C- La pose d'une sonde gastrique et d'une sonde vésicale
- D- Un lavement colique
- E- Une coloscopie diagnostique

Question 4 : L'examen de choix pour étayer le diagnostic étiologique est:

- A- L'échographie abdominale
- B- L'opacification colique basse aux hydrosolubles
- C- La coloscopie
- D- Le scanner abdominal avec opacification vasculaire après correction de la fonction rénale
- E- L'IRM abdominale

49- Patient âgé de 32 ans a présenté depuis 7 jours une douleur de la fosse iliaque droite avec fièvre non chiffrée pour laquelle il s'est automédiqué par du Clamoxyl et de l'Analgan. Après deux jours l'évolution s'est faite vers l'apyrexie et l'atténuation des douleurs. Quarante-huit heures après, reprise des douleurs de la FID avec apparition de diarrhées pour lesquels il a consulté un médecin de libre pratique où l'examen avait trouvé une température à 37.8°C avec masse au niveau de la FID, lui a prescrit du Smecta et du Flagyl avec demande d'échographie abdominale non faite par le patient. Après 3 jours de traitement, il a ressenti une accentuation des douleurs de la FID qui se sont généralisées à tout l'abdomen motivant le patient à consulter. L'examen trouve une T à 40°C, un faciès terreux, une tachycardie à 112 bpm, une polypnée avec contracture abdominale généralisée.

Question 1 : quel tableau présente ce patient ?

Question 2 : quelles sont les fautes commises dans l'histoire de ce patient ?

Question 3 : détailler les étapes de prise en charge du patient.

Question 4 : Quel est le pronostic du patient ? Justifier

50- Une jeune fille de 15 ans, sans antécédents particuliers, est hospitalisée en urgence. Le tableau initial dans la matinée était marqué par des douleurs de la fosse iliaque droite, avec malaise, nausée et fièvre à 37,8 C. Après une accalmie partielle de quelques heures, sont progressivement apparus des douleurs abdominales diffuses et des vomissements avec arrêt du transit. L'examen de l'abdomen montre une défense abdominale diffuse prédominant dans la fosse iliaque droite. La température est à 39,8 C ; il y a une leucocytose à 23700 globules blancs. L'abdomen sans préparation debout de face met en évidence des niveaux hydroaériques centraux multiples.

1. Le(s) signe(s) en faveur de l'origine appendiculaire de la péritonite est (sont):

- A. début et prédominance des signes à droite
- B. douleur au TR
- C. niveaux hydroaériques centraux
- D. Syndrome infectieux.
- E. La contracture abdominale diffuse

2. Le tableau présenté dans ce cas fait évoquer :

- A. une péritonite par diffusion
- B. une péritonite asthénique
- C. une pelvipéritonite
- D. une péritonite généralisée
- E. un plastron appendiculaire abcédé

3. Par quoi peut-on expliquer les niveaux hydro aériques du grêle (une ou plusieurs propositions est/sont exacte(s)) :

- A- un appendice en position mésocolique
- B- iléus paralytique par irritation de la séreuse péritonéale
- C- occlusion sur bride
- D- occlusion par invagination
- E-Entérocolite nécrosante

51- Patiente âgée de 66 ans diabétique, connue porteuse d'une lithiasie vésiculaire symptomatique programmée pour cholécystectomie, se présente pour crise inhabituelle de douleur continue de l'hypochondre droit avec fièvre pour laquelle la patiente a pris son traitement habituel d'antispasmodiques pendant 4 jours. L'évolution s'est faite vers l'aggravation brutale et la généralisation de la douleur à tout l'abdomen avec vomissements. L'examen à l'admission trouve une patiente obnubilée, fébrile à 39°C, TA à 14/7, pouls à 102 bpm, FR à 24 c/min. l'examen de l'abdomen note une défense abdominale généralisée maximale au niveau de l'HCD, le TR est douloureux. à la biologie GB = 18200, amylasémie à 2 fois la normale. L'échographie abdominale met en évidence un épanchement intra péritonéal libre avec vésicule biliaire lithiasique en semi réplétion, avec présence des bulles d'air au sein de sa paroi, voies biliaires fines.

Question 1 : Le tableau présenté par la patiente cadre avec :

- A- Une cholécystite aigue
- B- Un abcès péri-vésiculaire
- C- Une péritonite biliaire généralisée
- D- Une pancréatite aigue grave
- E- Une péritonite chimique

Question 2 : La complication présentée par la patiente aurait pu être évitée si :

- A- Une cholécystectomie à froid avait été faite
- B- Une antibiothérapie à tropisme biliaire avait été administrée
- C- Une sphinctérotomie endoscopique avait été faite
- D- La patiente avait consulté précocement
- E- La patiente n'avait pas pris de traitement anti-spasmodique

Question 3 : L'aspect de la vésicule biliaire à l'échographie cadre avec :

- A- Une cholécystite gangréneuse
- B- Une vésicule biliaire perforée
- C- Une fistule bilio-digestive

- D- Une cholécystite chronique
- E- Une vésicule scléro-atrophique

Question 4 : Le traitement de la patiente comporte :

- A- Une antibiothérapie à tropisme biliaire
- B- Une cholécystectomie avec toilette péritonéale
- C- Une cholécystostomie
- D- Un drain biliaire externe
- E- Un drainage sous hépatique

52- Patient âgé de 72 ans, hypertendu, porteur d'une tumeur du sigmoïde en cours d'exploration, consulte pour des douleurs abdominales d'installation brutale, évoluant depuis 24 heures, débutant au niveau de la fosse iliaque gauche puis rapidement généralisées à tout l'abdomen. L'examen physique trouve un patient prostré, une température à 40°C, une langue sèche avec plis cutané persistant, une TA à 9,5/6, un pouls à 115 bpm, une fréquence respiratoire à 29c/mn, une défense abdominale généralisée à maximum au niveau de la fosse iliaque gauche avec au toucher rectal, un cul de sac de Douglas bombant et douloureux. La sonde vésicale ne ramène que quelques cc d'urines concentrées.

1 - Quel est le diagnostic à évoquer chez ce patient ?

2 - Quelle est l'étiologie la plus probable ?

3 – Quels sont les éléments de gravité chez ce patient ?

4 – Quelle est votre conduite thérapeutique ?

53- Dans les péritonites aiguës par perforation :

- A- Le début de la symptomatologie est souvent progressif
- B- Les signes infectieux sont toujours absents au début
- C- Le diagnostic est en général basé sur l'examen clinique
- D- Sur l'abdomen sans préparation il existe toujours un pneumopéritoine
- E- La contracture abdominale est remplacée par une défense généralisée

Rep :

54- La péritonite aiguë d'origine appendiculaire :

- A- Est toujours secondaire à la rupture d'un abcès appendiculaire
- B- Est toujours secondaire à la perforation de l'appendice
- C- Est de meilleur pronostic quand elle survient en trois temps
- D- Peut être traitée par voie laparoscopique
- E- Donne souvent un pneumopéritoine à l'ASP si l'appendice est perforé

Rep :

55- La perforation d'ulcère gastro-duodénal :

- A- survient uniquement sur un estomac vide
- B- Est caractérisée par un début brutal de la symptomatologie
- C- L'état septique du patient est souvent évident dès le début
- D- Peut inaugurer la maladie ulcéreuse
- E- Est précédée par une hémorragie digestive d'origine ulcéreuse

Rep :

56- L'abcès du cul de sac de Douglas :

- A- Peut se manifester par un tableau d'occlusion fébrile
- B- Peut être suspecté au TR
- C- Peut donner un psoitis
- D- Peut survenir au décours d'une appendicectomie pour appendice latéro-caecal interne.
- E- Peut être traité par rectotomie antérieure

Rep :

57- En faveur de la gravité d'une péritonite aigue on retient :

- A- La présence d'une fièvre élevée
- B- La contracture abdominale
- C- L'insuffisance rénale
- D- Le terrain diabétique
- E- L'origine appendiculaire

Rep :

58- Cas clinique :

Une femme âgée de 32 ans consulte pour douleurs abdominales avec vomissements évoluant depuis 24 heures. A l'examen sa température est à 38,5°C, et elle présente une défense abdominale maximale à l'étage sous-ombilical du côté droit. L'examen gynécologique trouve des pertes vaginales d'odeur fétide et un dispositif intra-utérin en place. A la biologie GB = 17000 EB/mm³, CRP = 78 mg, le dosage de bêta HCG confirme l'absence de grossesse. L'échographie abdomino-pelvienne montre un épanchement intra abdominal de moyenne abondance sans autres anomalies. L'appendice n'était pas vu.

Question 1 :

Devant ce tableau clinique vous évoquez le(s) diagnostic(s) suivant(s) :

- A- Abscès du cul de sac de Douglas
- B- Pelvipéritonite
- C- Péritonite appendiculaire
- D- Une appendicite méso-coeliaque non compliquée
- E- Une péritonite asthénique

Rep :

Question 2 :

Un scanner abdominal a été pratiqué montrant un appendice de 6 mm de diamètre avec un abcès tubo-ovarien droit. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A- Abscès du cul de sac de Douglas
- B- péritonite appendiculaire
- C- péritonite génitale
- D- péritonite asthénique
- E- appendicite pelvienne

Rep :

Question 3 :

Le traitement de cette patiente comporte :

- A- une antibiothérapie
- B- une appendicectomie
- C- un drainage percutané
- D- une toilette péritonéale
- E- une annexectomie droite

59- Cas clinique :

Un patient âgé de 55 ans coronarien, consulte pour douleurs abdominales d'installation brutale au niveau épigastrique évoluant depuis 3 heures. L'examen trouve une température à 37,5°C avec une contracture abdominale généralisée. Vous évoquez la perforation d'ulcère gastro-duodénal. Vous pratiquez une radiographie d'ASP debout centrée sur les coupes, celle-ci ne montre pas d'anomalies, ainsi qu'un bilan inflammatoire normal.

Question 1 :

Devant ce tableau clinique :

- A- le diagnostic d'ulcère perforé est éliminé
- B- le diagnostic d'ulcère perforé reste le plus probable
- C- le diagnostic de perforation ulcéreuse colmatée est le plus probable
- D- le diagnostic de poussée hyperalgique d'ulcère GD est le plus probable
- E- le diagnostic d'IDM dans sa forme abdominale est probable

Rep :

Question 2 :

Afin d'étayer le diagnostic, votre conduite comportera :

- A- une fibroscopie digestive haute
- B- un traitement d'épreuve par les IPP
- C- un scanner abdominal
- D- un ECG avec dosage des troponines
- E- un TOGD

